CẨM NANG TOÀN DIỆN: VIÊM PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM

Giải phẫu • Sinh lý bệnh • 3 Giai đoạn tiến triển • 4 Thể lâm sàng • Chẩn đoán phân biệt • Phác đồ EBM & Cờ đỏ

I. ĐỊNH NGHĨA & BẪY PHÂN BIỆT GIẢI PHẪU: VIÊM PHẾ QUẢN VS VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN

Định nghĩa: Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm cấp tính của niêm mạc cây phế quản lớn và trung bình (từ phế quản gốc đến phế quản phân thùy — nơi thành phế quản **vẫn còn sụn và tuyến tiết nhầy**).

Tiêu chí so sánh	Viêm phế quản (Bronchitis)	Viêm tiểu phế quản (Bronchiolitis)
Vị trí tổn thương	Phế quản lớn & vừa (thành có sụn nâng đỡ, có tuyến tiết nhầy).	**Tiểu phế quản tận & hô hấp** (< 2 mm, **hoàn toàn không có sụn**).
Lứa tuổi ưu thế	Trẻ lớn, trẻ mẫu giáo, học đường (> 2 tuổi).	**Trẻ nhũ nhi < 2 tuổi** (đặc biệt đỉnh điểm lứa tuổi < 6 tháng).
Cơ chế tắc nghẽn	Phù nề niêm mạc + **tăng tiết dịch nhầy trong lòng ống**.	Phù nề + hoại tử biểu mô $ ightarrow$ **tắc nút nhầy sụp đổ tiểu phế quản** (do không có sụn).
Dấu hiệu suy hô hấp	**Hiếm khi suy hô hấp** (trừ thể co thắt nặng hoặc có bệnh nền).	**Suy hô hấp rầm rộ**, ứ khí phế nang, rút lõm ngực dữ dội, thở nhanh.
Ran nghe phổi	**Ran ngáy, ran rít, ran ẩm to hạt** (thay đổi sau khi ho/vỗ rung).	**Ran rít, ran ngáy, ran ẩm nhỏ hạt / ran nổ** mịn cuối thì hít vào.

II. CĂN NGUYÊN GÂY BỆNH: 85 – 90% LÀ VIRUS

1. VIRUS (ĐẠI ĐA SỐ 85–90%) — CHÍNH

- **Rhinovirus** (cảm lạnh lan xuống phế quản).
- **RSV** (Virus hợp bào hô hấp).
- **Cúm A / B (Influenza)**, Parainfluenza.
- **Adenovirus**, Human Metapneumovirus (hMPV).
- *Ý nghĩa:* Bệnh lý **tự giới hạn (self-limiting)**, kháng sinh không rút ngắn thời gian bệnh!

2. VI KHUẨN (HIẾM GẶP CẤP) — ĐẶC BIỆT

- **Vi khuẩn không điển hình:** *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae* (ưu thế trẻ > 5 tuổi, ho dai dẳng).
- **Ho gà (*Bordetella pertussis*):** Cơn ho rũ rượi, tím tái, thở rít sau ho, nôn sau ho.

3. THỂ KÉO DÀI (PBB) — BIOFILM

- **Viêm phế quản kéo dài vi khuẩn (PBB):**
- *Haemophilus influenzae* không định type (NTHi).
- *Streptococcus pneumoniae*, *M. catarrhalis*.
- Cơ chế tạo màng **Biofilm** dai dẳng trên niêm mạc.

III. DIỄN TIẾN LÂM SÀNG QUA 3 GIAI ĐOẠN (10 – 14 NGÀY)

PHA 1: KHỞI PHÁT / VIÊM KHÔ — NGÀY 1 - 3

- Viêm long hô hấp trên: Hắt hơi, sổ mũi trong, nghẹt mũi.
- Sốt nhẹ hoặc vừa ($37.5 - 38.5^\circ ext{C}$).
- Ho khan, rát cổ họng, cảm giác đau tức sau xương ức khi ho.
- Nghe phổi: Rì rào phế nang rõ, chưa có ran bệnh lý.

PHA 2: XUẤT TIẾT & Ứ ĐỌNG — NGÀY 4 - 8

- Ho đờm, ho lọc xọc. Trẻ nhỏ nuốt đờm kích thích nôn trớ.
- Đờm đổi sang màu **VÀNG / XANH**.
- ⚠ *Bẫy:* Đờm vàng/xanh do men Myeloperoxidase của xác bạch cầu, **KHÔNG PHẢI do vi khuẩn**!
- Nghe phổi: **Ran ngáy, ran rít, ran ẩm to hạt** (thay đổi sau ho).

PHA 3: LUI BỆNH & HỒI PHỤC — NGÀY 9 - 14

- Cắt sốt hoàn toàn, trẻ chơi ngoan, ăn uống bình thường trở lại.
- Đờm trong và loãng dần, giảm tần số cơn ho.
- Phản xạ tăng nhạy cảm đường thở (ho khan nhẹ) có thể còn kéo dài thêm 2–3 tuần.

IV. BỐN THỂ LÂM SÀNG THƯỜNG GẶP TRÊN THỰC TẾ

Thể lâm sàng	Đặc điểm bệnh cảnh & Tiêu chuẩn nhận diện	Xử trí trọng tâm
1. Viêm phế quản cấp đơn thuần	Diễn tiến đúng 3 pha tự giới hạn, trẻ tỉnh táo, không thở nhanh theo tuổi, không rút lõm lồng ngực.	Chăm sóc hỗ trợ, bù dịch, vệ sinh mũi. **Không dùng kháng sinh**.
2. Viêm phế quản co thắt (Wheezy Bronchitis)	Cơ địa dị ứng / tăng nhạy cảm sau virus. Ho kèm **khò khè (wheezing)**, thì thở ra kéo dài, ran rít ran ngáy rộ 2 phế trường.	**Khí dung Salbutamol** (đánh giá đáp ứng). Kháng Histamin hoặc Corticoid nếu nặng.
3. Viêm phế quản kéo dài do vi khuẩn (PBB)	**Ho đờm liên tục > 4 tuần**, không có cờ đỏ bệnh lý khác, không dấu hiệu suyễn. Do vi khuẩn tạo Biofilm (*H. influenzae, S. pneumoniae*).	**Amoxicillin - Clavulanate (Augmentin)** liều 80–90 mg/kg/ngày trong **2 tuần liên tục**.
4. Viêm phế quản phổi (Bronchopneumonia)	Viêm lan từ phế quản vào tận nhu mô phế nang. Trẻ **thở nhanh theo tuổi, rút lõm lồng ngực, sốt cao, ran ẩm nhỏ hạt khu trú**.	Thực chất là **VIÊM PHỔI**. Xử trí theo phác đồ Viêm phổi (nhập viện, kháng sinh).

CẨM NANG TOÀN DIỆN: VIÊM PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM (TIẾP THEO)

Chẩn đoán phân biệt • Cận lâm sàng • Chiến lược điều trị EBM • Bẫy thuốc & Cờ đỏ tái khám

V. BỐN CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT TẠI GIƯỜNG (BẮT BUỘC KHI THI LÂM SÀNG)

Bệnh lý phân biệt	Điểm nhận diện & Cờ đỏ đối soát	Điểm khác biệt với Viêm phế quản
1. Viêm phổi	• **Thở nhanh theo lứa tuổi**, rút lõm lồng ngực rõ. • Nghe phổi có vùng giảm thông khí, **ran ẩm nhỏ hạt khu trú**. • X-quang: Đám mờ thâm nhiễm hoặc đông đặc nhu mô.	Viêm phế quản **không thở nhanh**, ran to hạt rải rác thay đổi sau ho, X-quang không có đông đặc nhu mô.
2. Hen phế quản (Suyễn)	• Tiền sử khò khè tái phát ≥ 3 lần; tiền sử dị ứng bản thân/gia đình. • Cơn khò khè xuất hiện ban đêm/gần sáng hoặc khi gặp dị nguyên. • **Đáp ứng cắt cơn nhanh và rõ rệt với Salbutamol xịt**.	Viêm phế quản thường xảy ra sau cảm cúm/viêm hô hấp trên, không có tính chất cơn chu kỳ lặp lại như hen.
3. Dị vật đường thở bỏ quên	• Có **hội chứng xâm nhập** (cơn ho sặc sụa, tím tái đột ngột khi ăn/chơi). • Khò khè dai dẳng, nghe phổi rì rào phế nang **giảm khu trú 1 bên**. • Điều trị kháng sinh và giãn phế quản hoàn toàn không cải thiện.	Viêm phế quản ran nghe đều 2 bên, không có hội chứng xâm nhập đột ngột.
4. Trào ngược dạ dày thực quản (GERD)	• Ho nhiều sau bữa ăn, ợ trớ, ho khi nằm ngủ. • Chậm tăng cân, khò khè tái diễn kéo dài.	Không sốt, không có viêm long hô hấp trên rầm rộ ban đầu.

VI. CẬN LÂM SÀNG: KHI NÀO CẦN LÀM? CHỈ ĐỊNH

- **X-quang ngực thẳng:**
  • **KHÔNG CHỈ ĐỊNH THƯỜNG QUY** cho viêm phế quản cấp đơn thuần.
  • *Chỉ định khi:* Nghi ngờ biến chứng viêm phổi (sốt cao không dứt, thở nhanh), nghi dị vật đường thở, hoặc điều trị không cải thiện.
  • *Hình ảnh nếu có:* Chỉ thấy **dày thành phế quản** (dấu hiệu "nòng súng" hoặc "đường ray xe lửa"), tăng đậm nhánh rốn phổi, phế trường 2 bên sáng đều.
- **Công thức máu & CRP:** Thường bình thường hoặc tăng nhẹ. Chỉ làm khi trẻ sốt cao li bì để loại trừ nhiễm khuẩn huyết/viêm phổi nặng.

VII. CHIẾN LƯỢC EBM: NÊN LÀM & TRÁNH EBM PRINCIPLES

NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM (DO)	TUYỆT ĐỐI TRÁNH (DON'T)
• Uống nhiều nước ấm (làm loãng đờm tự nhiên tốt nhất). • Vệ sinh mũi họng, hút thông thoáng trước ăn/ngủ. • Khí dung Salbutamol nếu có co thắt. • Kháng sinh CHỈ KHI có chỉ định rõ ràng.	• KHÔNG dùng kháng sinh bừa bãi. • **CẤM THUỐC ỨC CHẾ HO** (Codeine). • Không lạm dụng Corticoid uống kéo dài. • Không dùng thuốc long đờm cho trẻ < 2 tuổi.

VII. CHI TIẾT SỬ DỤNG THUỐC & QUY TẮC KHÁNG SINH CHUẨN

1. NGUYÊN TẮC DÙNG KHÁNG SINH (CÂU HỎI THI) ANTIBIOTICS

- **Viêm phế quản cấp đơn thuần: 100% KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH.** Bệnh cần 10–14 ngày để tự đào thải virus.
- **4 CHỈ ĐỊNH DÙNG KHÁNG SINH BẮT BUỘC:**
  1) **PBB (Viêm phế quản kéo dài vi khuẩn > 4 tuần):** *Amoxicillin - Clavulanate (Augmentin)* 80–90 mg/kg/ngày x 2 tuần liên tục.
  2) **Nghi *Mycoplasma pneumoniae* (> 5 tuổi, ho dai dẳng):** *Azithromycin* 10 mg/kg/ngày x 5 ngày.
  3) **Ho gà (*B. pertussis*):** *Azithromycin* để giảm lây lan và mức độ nặng.
  4) **Có bằng chứng bội nhiễm vi khuẩn rõ:** Viêm tai giữa mủ cấp, viêm phổi thùy xuất hiện sau đó.

2. ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG & THUỐC HỖ TRỢ SYMPTOMATIC

- **Bù nước:** Nước là thuốc làm loãng đờm tự nhiên tốt nhất! Uống nước ấm, bú tăng cường giúp dịch phế quản lỏng ra.
- **Thuốc giãn phế quản (Salbutamol khí dung):**
  • *Chỉ định:* CHỈ dùng khi có **co thắt phế quản** (khò khè, ran rít/ngáy, thở ra kéo dài).
  • *Liều:* **0.15 mg/kg/lần** (min 1.25 mg, max 2.5–5 mg) pha NaCl 0.9% khí dung. Đánh giá lại sau 20 phút. Nếu không đỡ $ ightarrow$ Ngừng khí dung!
- **Thuốc giảm ho: CẤM TUYỆT ĐỐI thuốc ức chế ho (Codeine, Dextromethorphan)** vì làm mất phản xạ ho gây ứ đờm, xẹp phổi. Trẻ > 1 tuổi ho nhiều mất ngủ có thể dùng **mật ong ấm** (2.5–5 mL).
- **Thuốc long đờm (Acetylcysteine, Ambroxol):** Thận trọng, không dùng cho trẻ < 2 tuổi vì nguy cơ tràn ngập đờm đường thở.

VIII. 6 "CỜ ĐỎ" BẮT BUỘC DẶN PHỤ HUYNH ĐƯA TRẺ ĐI CẤP CỨU / TÁI KHÁM NGAY:

1. **Thở nhanh** hoặc xuất hiện **rút lõm lồng ngực** (báo hiệu bệnh đã chuyển biến thành Viêm phổi!).
2. **Khó thở, thở rên (grunting), tím tái** môi/đầu chi, phập phồng cánh mũi.
3. Trẻ **bỏ bú, bú kém, nôn tất cả mọi thứ** uống vào.
4. **Li bì, lơ mơ**, khó đánh thức hoặc xuất hiện **co giật**.
5. Sốt cao liên tục $> 38.5 - 39^\circ ext{C}$ quá 3 ngày không hạ hoặc sốt vọt trở lại sau khi đã thuyên giảm.
6. Ho đờm kéo dài liên tục quá 3–4 tuần không thuyên giảm (nghi ngờ PBB hoặc lao/dị vật).